

De datos a decisiones: la IA en la práctica clínica

Josep Franch · EAP Raval Sud (ICS) y DAP.cat (IDIAP Jordi Gol), Barcelona

Objetivo

Esta charla muestra cómo la inteligencia artificial puede mejorar la práctica clínica en diabetes. Parte de nuestra experiencia investigadora con datos reales de atención primaria. Se estructura en cuatro preguntas: dato, clasificar, predecir y decidir.

El dato

La atención primaria genera el mayor volumen de información clínica del sistema. Sin embargo, casi siempre se aprovecha solo para memorias anuales. Con la base SIDIAP, millones de historias clínicas electrónicas de Cataluña se convierten en investigación útil.

Clasificar

La diabetes tipo 2 es muy heterogénea. Pusimos a prueba en una cohorte propia los subgrupos descritos en Escandinavia. Los perfiles aparecen, pero no son plenamente estables, según publicamos en revistas científicas internacionales. La lección es clara: ningún algoritmo es transferible sin comprobarlo en nuestra población.

Predecir

La diabetes no es una fotografía, es una película. Por eso modelamos su evolución con aprendizaje profundo y modelos fundacionales, junto a ingenieros biomédicos. Estos modelos anticipan complicaciones, nuevas comorbilidades y cambios de tratamiento.

Decidir

Predecir no es decidir. El clínico se pregunta qué ocurrirá si añade un fármaco. Desarrollamos herramientas que simulan escenarios de tratamiento y apoyan la decisión individual.

Oportunidades y límites

La IA abre la puerta a la historia clínica aumentada, la monitorización continua, los asistentes conversacionales y los gemelos digitales. También plantea riesgos: errores con apariencia de precisión, sesgos y falta de transparencia. Aún no hay ensayos que demuestren un mejor pronóstico.

Mensaje final

El futuro no consiste en elegir entre inteligencia artificial e inteligencia clínica. Consiste en que trabajen juntas para tomar mejores decisiones.